

DIABETES Y CUIDADO DENTAL

Guía para tener una boca sana

Dra. Diana Rocío Orué





¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CEPILLADO CORRECTO DE LOS DIENTES Y EL USO DE HILO DENTAL EN PACIENTES CON LA DIABETES?

Si eres diabético, verás por qué es importante el cuidado dental y cómo hacerlo bien.





Cuando tienes diabetes, un nivel alto de azúcar en sangre puede causar daño en todo el cuerpo, hay mayor riesgo de infecciones e inflamaciones de las encías

**+
¿CUÁL ES LA BUENA NOTICIA?+
● LA PREVENCIÓN ESTÁ EN TUS
MANOS.**



+ POR QUÉ LA DIABETES INFLUYE + EN LA SALUD BUCODENTAL ?



- El exceso de glucosa favorece el crecimiento de bacterias.
- La saliva cambia su composición (menos protectora).
- Respuesta baja ante las infecciones, debido a la disminución de la defensa del organismo que dificulta la curación.



+ SALIVA DE PACIENTE SANO VS SALIVA DEL PACIENTE DIABÉTICO +



Saliva normal

- Líquido transparente y ligeramente viscoso
- pH: 6.5 – 7.5 (casi neutro)
- Mantiene la humedad, protege dientes y encías
- Controla bacterias y facilita la digestión



Saliva en paciente diabético

- Más ácida (pH: 5.5 – 6.0)
- Puede verse espumosa, espesa o pegajosa
- Menor producción por alteración de glándulas salivales
- Provoca sequedad bucal, mal aliento, y mayor riesgo de caries, infecciones y enfermedad periodontal





Caries, enfermedades de las encías y otros problemas ya sea que tengas diabetes de tipo 1 o tipo 2, controlar tu nivel de azúcar en sangre es fundamental. Mientras más alto sea el nivel de azúcar en sangre, mayor será el riesgo de:

- ✓ **CARIES**
 - ✓ **ENFERMEDADES DE ENCÍAS**
 - ✓ **GINGIVITIS / PERIODONTITIS**
 - ✓ **AFTAS**
 - ✓ **SEQUEDAD DE BOCA**
 - ✓ **MAL ALIENTO**
 - ✓ **CANDIDIASIS ORAL**
- 



Cuidado dental adecuado para ayudar a prevenir el daño en los dientes y las encías, toma el cuidado dental y de la diabetes con seriedad:

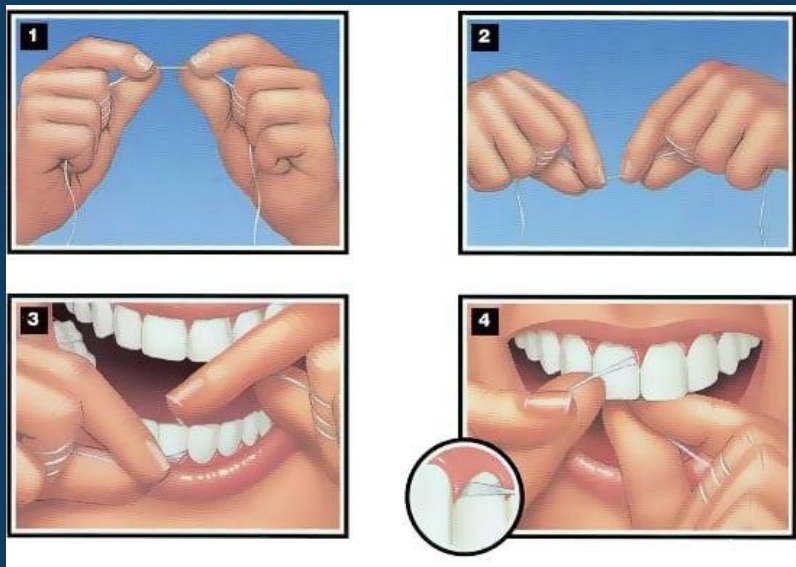
- Comprométete a controlar tu diabetes.
- Cepíllate los dientes al menos dos veces por día.
- Usa hilo dental por lo menos una vez al día.
- Programa visitas regulares al dentista.
- Mírate las encías para detectar signos tempranos de enfermedades de las encías.
- No fumar.





MEDIDAS DE HIGIENE – TÉCNICA CORRECTA







MANIFESTACIONES BUCALES DE LA DIABETES

Periodontitis

Xerostomía



Candidiasis oral

Aftas

Estomatitis

Lenguas fisuradas

Liquen Plano





Manifestaciones bucales de la diabetes





ANTES DEL TRATAMIENTO



- ❖ Convendría conocer el tipo de diabetes. Paciente controlado o no controlado
- ❖ La edad que comenzó.
- ❖ Los medicamentos que recibe.
- ❖ El método de administración.
- ❖ El cumplimiento de las órdenes médicas.
- ❖ La técnica de monitoreo.
- ❖ El antecedente de complicaciones diabéticas.
- ❖ Los resultados más reciente de pruebas de laboratorio.
- ❖ El nombre y dirección del médico tratante.





PROFILAXIS ANTIBIÓTICA MÁS UTILIZADA

*Amoxicilina 2 g 1 hora antes y 1 g una hora después del
procedimiento odontológico.

Tabla Nro. 2. Dosis de medicamentos utilizados en profilaxis antibiótica

ANTIBIOTICO	DOSIS ADULTO	DOSIS NIÑOS
	Dosis de 30 a 60 minutos antes del tratamiento	
Amoxicilina	2 g VO	50 mg/kg VO
Amoxicilina + Ac. Clavulanico	2 g + 125 mg VO 2 g + 200 mg VI	50 + 6.25 mg/kg VO 50 + 5 mg/kg VI
Ampicilina	2 g IM o IV	50 mg/kg IM o IV
*Cefazolina *Ceftriaxona	1 g IM o IV	25 mg/kg IM o IV
*Cefalexina o cefadroxilo	2 g VO	50 mg/kg VO
+Clindamicina	600mg VO 600mg IV	20 mg/kg VO 15 mg/kg IV
+Claritromicina o azitromicina	500 mg VO	15 mg/kg VO
+Gentamicina	1,5 mg/kg IM	1,5 mg/kg IM
+Vancomicina	1 g IV	20 mg/kg IV

***No se debe utilizar cefalosporinas en casos de paciente que presentaron antecedentes de anafilaxia, angioedema o urticaria después de haber sido administrado penicilina.**

+Pacientes con alergia a la penicilina administrar: Azitromicina, Gentamicina, Clindamicina, Vancomicina, Gentamicina

Vía de administración: vía oral (VO), Intra venosa(IV), Intra muscular(IM)

FUENTE: modificado de: Gutiérrez J. y cols.⁽³⁵⁾ Documento de consenso sobre la utilización de profilaxis antibiótica en cirugía y procedimientos dentales; : María Teresa Espinosa Meléndez.⁽³⁴⁾ Farmacología y terapéutica en odontología fundamentos y guía práctica

+ DURANTE EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO +

1. Sangrado excesivo

- Mayor fragilidad capilar y dificultad para coagular.



2. Cicatrización lenta

- La hiperglucemia retrasa la reparación de tejidos.



3. Infecciones postoperatorias

- Disminución de las defensas y aumento de bacterias orales.



4. Riesgo de hipoglucemia

- Si el paciente acude sin haber comido o toma medicación sin control.



5. Dolor e inflamación prolongados

- Por respuesta inflamatoria alterada.



6. Mayor riesgo de fracaso en tratamientos

- **Implantes, extracciones o cirugías pueden tener menor éxito si la glucosa no está controlada.**





DESPUÉS DEL TRATAMIENTO



2. Alimentación adecuada

- No saltar comidas; optar por alimentos blandos y evitar azúcares.

3. Seguir las indicaciones médicas

- Tomar los medicamentos (antibióticos o analgésicos) según la receta.

4. Higiene bucal suave y constante

- Cepillarse con cepillo blando y enjuagues sin alcohol.
- Evitar enjuagues fuertes o buches enérgicos las primeras horas.



6. No fumar ni consumir alcohol

- Retrasan la cicatrización y aumentan el riesgo de infección.

7. Control odontológico y médico

- Revisar la herida y ajustar medicación si es necesario.



COMPLICACIONES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS POST-QUIRÚRGICAS

- Alveolitis.
- Osteomielitis.
- Absceso dentoalveolar.
- Shock séptico.
- Endocarditis bacteriana.





“Controlar tu diabetes al mismo tiempo que tu salud bucodental es la clave para una mejor calidad de vida con menos complicaciones.”



+ GRACIAS +

